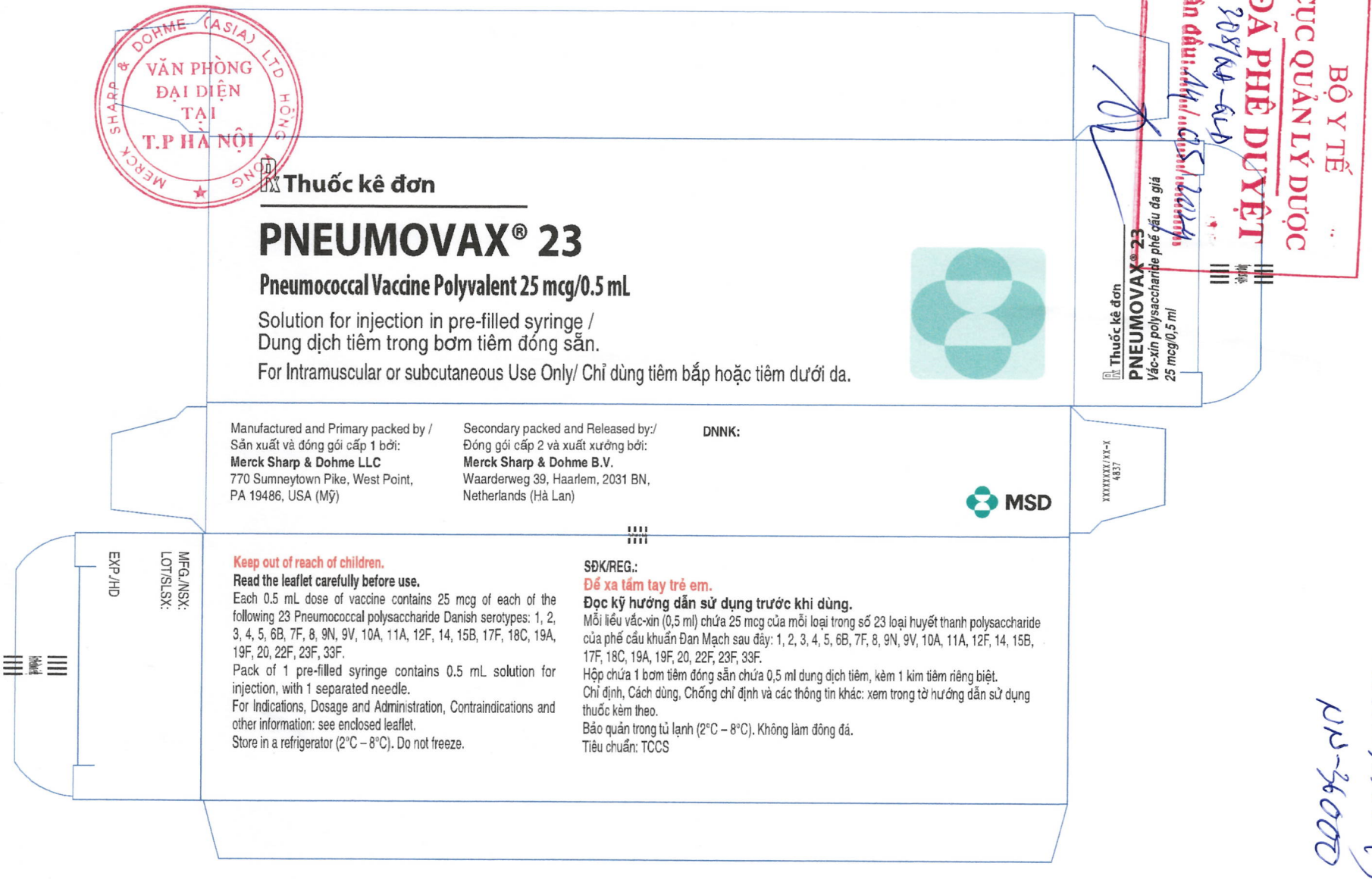
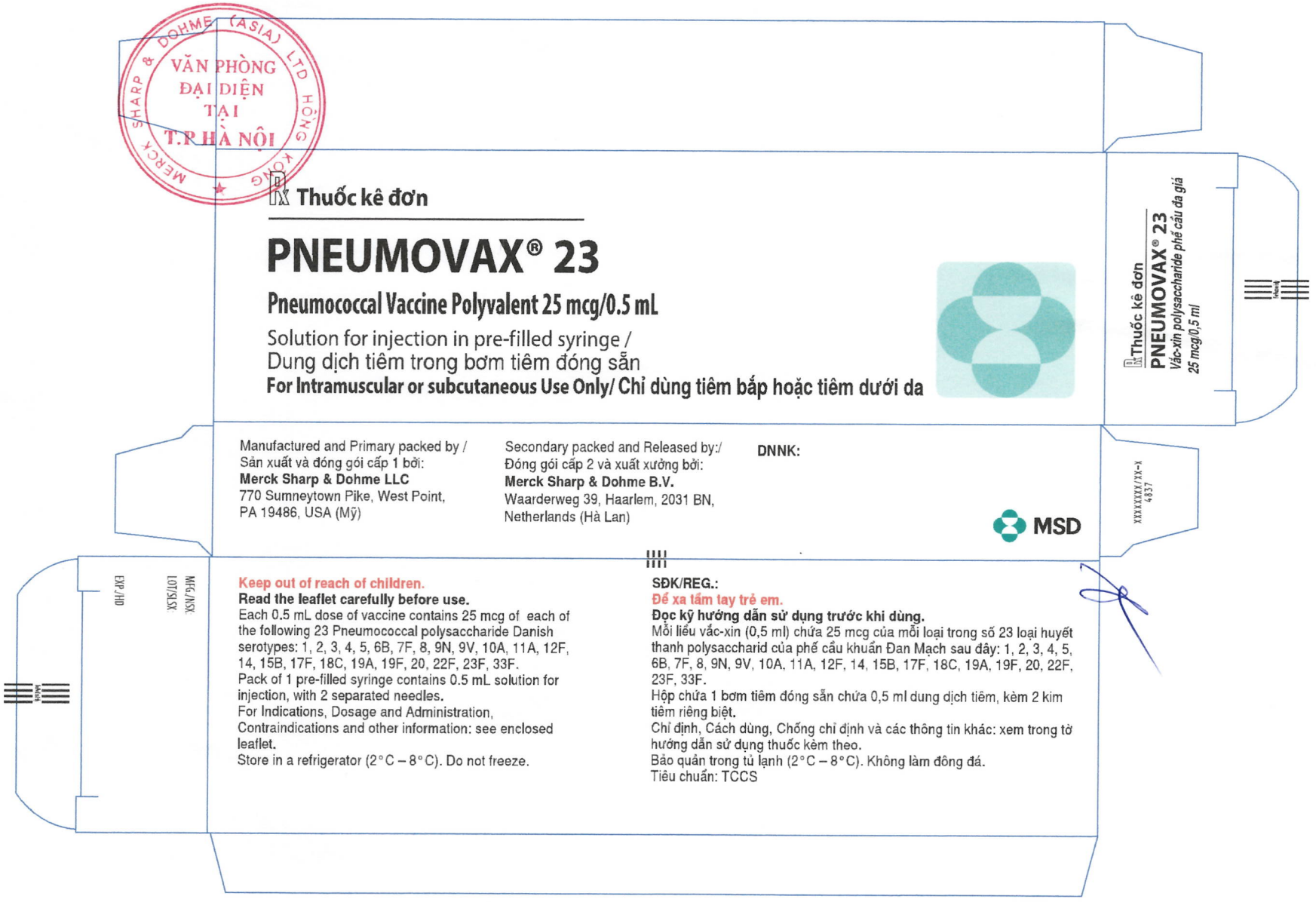
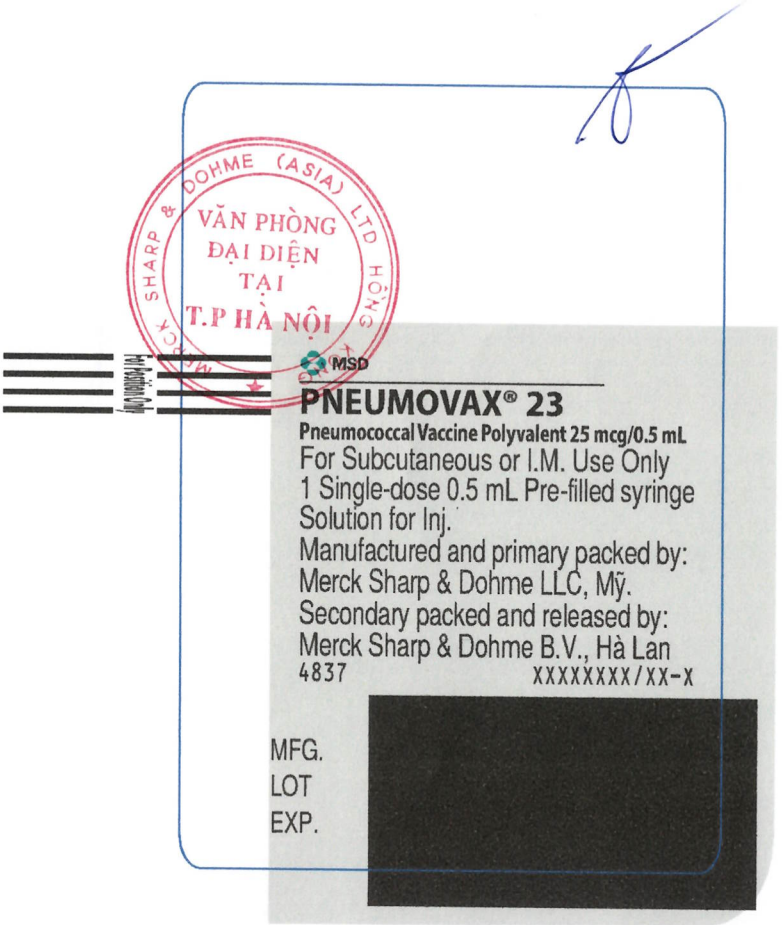
OUTER CARTON - PACK OF 1 PRE-FILLED SYRINGE CONTAINS 0.5 ML SOLUTION FOR INJECTION, WITH 1 SEPARATED NEEDLE



OUTER CARTON - PACK OF 1 PRE-FILLED SYRINGE CONTAINS 0.5 ML SOLUTION FOR INJECTION, WITH 2 SEPARATED NEEDLES




MERCK SHARP & DOHME (ASIA) LTD HONG KONG
VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN
TẠI
T.P HÀ NỘI
MSD
PNEUMOVAX® 23
Pneumococcal Vaccine Polyvalent 25 mcg/0.5 mL
For Subcutaneous or I.M. Use Only
1 Single-dose 0.5 mL Pre-filled syringe
Solution for Inj.
Manufactured and primary packed by:
Merck Sharp & Dohme LLC, Mỹ.
Secondary packed and released by:
Merck Sharp & Dohme B.V., Hà Lan
4837
XXXXXXXX/XX-X
MFG.
LOT
EXP.

IPC-V110-I-022023
000025637-VN_20231018

Hướng dẫn sử dụng

Rx

MERCK SHARP & DOHME (ASIA) LTD HỒNG KÔNG
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI T.P HÀ NỘI

PNEUMOVAX® 23

(Vắc-xin polysaccharide phế cầu

Dung dịch tiêm bắp hoặc tiêm dưới da)

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

Thành phần hoạt chất:

Mỗi liều vắc-xin (0,5 ml) chứa 25 mcg của mỗi loại trong số 23 loại huyết thanh polysaccharide của phế cầu khuẩn Đan Mạch sau đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F.

Thành phần tá dược: Phenol, natri chloride, nước pha tiêm

DẠNG BÀO CHẾ

Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn.

Vắc-xin này là dung dịch trong suốt, không màu.

CHỈ ĐỊNH

Vắc-xin polysaccharide phế cầu được khuyến cáo để tạo miễn dịch chủ động chống lại bệnh do phế cầu khuẩn ở trẻ em từ 2 tuổi trở lên, thanh thiếu niên và người lớn.

Xem phần **Đặc tính dược lực học** để biết thông tin về việc bảo vệ chống lại các týp huyết thanh phế cầu khuẩn đặc hiệu.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG

Lịch tiêm chủng vắc-xin polysaccharide phế cầu phải dựa trên các khuyến cáo chính thức.

Bản quyền ©2022 thuộc về Merck & Co., Inc.,Rahway, NJ, Hoa Kỳ và các chi nhánh của nó.
Mọi quyền đều được bảo lưu.

Liều lượng

Tiêm chủng cơ bản:

Người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên - một liều 0,5 ml bằng cách tiêm bắp hoặc tiêm dưới da. Không khuyến cáo sử dụng vắc-xin polysaccharide phế cầu ở trẻ em dưới 2 tuổi vì độ an toàn và hiệu quả của vắc-xin này chưa được xác định và đáp ứng kháng thể có thể kém.

Liều dùng đặc biệt:

Khuyến cáo rằng tốt nhất nên sử dụng vắc-xin phế cầu ít nhất 2 tuần trước phẫu thuật cắt bỏ lách chọn lọc hoặc bắt đầu hóa trị liệu hoặc điều trị ức chế miễn dịch khác.

Nên tránh tiêm chủng vắc-xin trong khi hóa trị hoặc xạ trị.

Sau khi hoàn thành hóa trị và/hoặc xạ trị đối với bệnh ung thư, đáp ứng miễn dịch đối với tiêm chủng có thể vẫn bị giảm. Không nên sử dụng vắc-xin sớm hơn 3 tháng sau khi hoàn thành liệu pháp đó. Sự trì hoãn lâu hơn có thể phù hợp đối với những bệnh nhân đã được điều trị tích cực hoặc kéo dài (xem phần **Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc**).

Những người bị nhiễm HIV (virus gây suy giảm miễn dịch ở người) không triệu chứng hoặc có triệu chứng nên được tiêm chủng càng sớm càng tốt sau khi đã được chẩn đoán xác định.

Tiêm chủng lại:

Một liều đơn 0,5 ml bằng cách tiêm bắp hoặc tiêm dưới da.

Thời gian cụ thể và nhu cầu tiêm chủng lại nên được xác định dựa trên các khuyến cáo chính thức hiện có.

Xem phần **Đặc tính dược lực học** để biết thông tin về đáp ứng miễn dịch sau khi tiêm chủng lại.

Không khuyến cáo tiêm chủng lại ở khoảng cách dưới 3 năm do tăng nguy cơ phản ứng bất lợi. Tỷ lệ phản ứng tại chỗ và, ở những người ≥ 65 tuổi, một số phản ứng toàn thân đã cho thấy là cao hơn sau khi tiêm chủng lại so với sau khi tiêm chủng cơ bản với khoảng cách 3-5 năm giữa các liều. Xem phần **Tác dụng không mong muốn của thuốc.**

Dữ liệu lâm sàng còn rất hạn chế liên quan đến việc sử dụng hơn 2 liều vắc-xin polysaccharide phế cầu.

Người lớn

Người lớn khỏe mạnh không nên tiêm chủng lại thường quy.

Có thể xem xét tiêm chủng lại cho những người có tăng nguy cơ nhiễm phế cầu khuẩn nghiêm trọng là những người đã sử dụng vắc-xin phế cầu hơn 5 năm trước hoặc những người đã được biết là giảm nhanh nồng độ kháng thể kháng phế cầu. Đối với các nhóm đối tượng được chọn (ví dụ những người không có lách) là những người được biết là có nguy cơ cao về nhiễm phế cầu khuẩn gây tử vong, có thể được xem xét tiêm chủng lại lúc 3 năm.

Trẻ em

Trẻ em khỏe mạnh không nên tiêm chủng lại thường quy.

Trẻ em từ 10 tuổi trở lên

Có thể được xem xét tiêm chủng lại theo khuyến cáo cho người lớn (xem ở trên).

Trẻ em từ 2-10 tuổi

Chỉ nên xem xét tiêm chủng lại sau 3 năm nếu trẻ có nguy cơ cao nhiễm phế cầu khuẩn (ví dụ những trẻ bị hội chứng thận hư, không có lách hoặc bệnh hồng cầu hình liềm).

Cách dùng

Một liều 0,5 ml từ một liều đơn vắc-xin polysaccharide phế cầu được tiêm bắp (IM) hoặc tiêm dưới da (SC).

Thận trọng đặc biệt khi hủy bỏ và xử lý khác

Cảm quan bình thường của vắc-xin này là dung dịch trong suốt, không màu.

Các sản phẩm dùng đường tiêm phải được kiểm tra bằng mắt về các tiểu phân ngoại lai và/hoặc sự đổi màu trước khi dùng. Trong trường hợp quan sát thấy một trong hai điều này, loại bỏ thuốc.

Cần sử dụng vắc-xin trực tiếp như được cung cấp; không cần thiết pha loãng hoặc pha.

Bất kỳ phần thuốc nào không dùng hoặc vật liệu thải đi phải được loại bỏ theo đúng quy định của địa phương.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Tạm ngừng việc sử dụng vắc-xin trong bất kỳ bệnh có sốt đáng kể nào, nhiễm khuẩn khác đang hoạt động hoặc khi một phản ứng toàn thân sẽ gây ra nguy cơ đáng kể trừ khi sự trì hoãn này có thể liên quan đến nguy cơ thậm chí còn cao hơn.

Vắc-xin polysaccharide phế cầu không bao giờ được tiêm vào mạch máu, và phải thận trọng để đảm bảo kim không đi vào mạch máu. Ngoài ra, không được tiêm vắc-xin trong da vì tiêm theo đường đó có liên quan đến tăng các phản ứng tại chỗ.

Nếu sử dụng vắc-xin này cho bệnh nhân bị ức chế miễn dịch do tình trạng bệnh có từ trước hoặc điều trị nội khoa (ví dụ liệu pháp ức chế miễn dịch như hóa trị hoặc xạ trị ung thư), có thể không đạt được đáp ứng kháng thể trong huyết thanh như dự kiến sau liều đầu tiên hoặc

liều thứ hai. Do đó những bệnh nhân như vậy có thể không được bảo vệ tốt chống lại bệnh phế cầu khuẩn như những người có miễn dịch bình thường.

Cũng như với bất kỳ loại vắc-xin nào, tiêm chủng bằng vắc-xin polysaccharide phế cầu có thể không dẫn đến sự bảo vệ đầy đủ cho tất cả những người được tiêm vắc-xin.

Đối với những bệnh nhân đang dùng liệu pháp ức chế miễn dịch, thời gian hồi phục đáp ứng miễn dịch thay đổi theo bệnh và trị liệu. Sự cải thiện đáng kể về đáp ứng kháng thể đã được quan sát thấy ở một số bệnh nhân trong 2 năm sau khi hoàn thành hóa trị liệu hoặc liệu pháp ức chế miễn dịch khác (có hoặc không có xạ trị), đặc biệt là khi khoảng cách giữa kết thúc điều trị và tiêm chủng vắc-xin phế cầu tăng lên (xem phần **Liều dùng và cách dùng**).

Cũng như với bất kỳ vắc-xin nào, cần phải luôn có sẵn các phương tiện điều trị đầy đủ bao gồm epinephrine (adrenaline) để sử dụng ngay lập tức nếu xảy ra phản ứng phản vệ cấp tính.

Không nên ngừng điều trị bằng kháng sinh dự phòng cần thiết chống nhiễm phế cầu khuẩn sau khi tiêm chủng vắc-xin phế cầu.

Cần thông báo cho những bệnh nhân đặc biệt có tăng nguy cơ nhiễm phế cầu khuẩn nghiêm trọng (ví dụ những người không có lách và những người đã dùng liệu pháp ức chế miễn dịch vì bất kỳ lý do nào) về nhu cầu có thể có đối với việc điều trị kháng khuẩn sớm trong trường hợp bệnh có sốt nặng, đột ngột.

Vắc-xin phế cầu có thể không hiệu quả trong việc phòng ngừa nhiễm khuẩn do gãy xương đáy sọ hoặc do sự rò rỉ dịch não tủy ra bên ngoài.

Một nghiên cứu lâm sàng về tiêm chủng cơ bản và tiêm chủng lại đã được thực hiện ở 629 người lớn ≥ 65 tuổi và 379 người lớn từ 50-64 tuổi. Dữ liệu thu được cho thấy tỷ lệ phản ứng bất lợi tại chỗ tiêm và toàn thân ở các đối tượng ≥ 65 tuổi không cao hơn so với tỷ lệ ở các đối tượng từ 50-64 tuổi. Cần lưu ý rằng, nói chung người cao tuổi có thể không dung nạp các can thiệp y khoa như người trẻ tuổi hơn; không thể loại trừ tần suất cao hơn và/hoặc mức độ nặng của phản ứng cao hơn ở một số người cao tuổi (xem phần **Liều dùng và cách dùng**).

Natri

Thuốc này chứa ít hơn 1 mmol (23 mg) natri mỗi đơn vị liều và được xem là về cơ bản không có natri.

Truy xuất nguồn gốc

Để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc của các thuốc sinh học, tên và số lô của sản phẩm được sử dụng phải được ghi rõ trong hồ sơ.

SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Các nghiên cứu trên động vật là không đủ kết luận về các ảnh hưởng đến độc tính đối với sinh sản (xem phần **An toàn tiền lâm sàng**). Không nên sử dụng vắc-xin này trong khi mang thai trừ khi thực sự cần thiết (lợi ích có thể có phải biện minh được cho bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy ra đối với thai).

Cho con bú

Chưa rõ liệu vắc-xin này có được bài tiết vào sữa mẹ hay không. Cần thận trọng khi sử dụng cho bà mẹ cho con bú.

Khả năng sinh sản

Vắc-xin này chưa được đánh giá trong các nghiên cứu về khả năng sinh sản.

ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa có nghiên cứu nào được thực hiện về ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

Có thể dùng đồng thời vắc-xin phế cầu với vắc-xin cúm miễn là sử dụng các kim tiêm và vị trí tiêm khác nhau.

Trong trường hợp không có nghiên cứu về sự tương hợp, không được trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

a. Tóm tắt hồ sơ về an toàn

Một nghiên cứu lâm sàng về tiêm chủng cơ bản và tiêm chủng lại đã được thực hiện ở 379 người lớn từ 50-64 tuổi và 629 người lớn ≥ 65 tuổi. Tỷ lệ phản ứng bất lợi tại chỗ tiêm về tổng thể ở nhóm người cao tuổi được tiêm chủng lại tương đương với tỷ lệ được quan sát thấy ở những người trẻ tuổi hơn được tiêm chủng lại.

Phản ứng tại chỗ tiêm đã xảy ra trong vòng 3 ngày sau khi tiêm chủng và thường hồi phục vào ngày thứ 5. Tỷ lệ phản ứng toàn thân và liên quan đến vắc-xin ở nhóm người cao tuổi được tiêm chủng lại tương đương với tỷ lệ được quan sát thấy ở những người trẻ tuổi hơn được tiêm chủng lại. Các biến cố bất lợi toàn thân về tổng thể thường gặp nhất như sau: suy nhược/mệt mỏi, đau cơ và nhức đầu. Điều trị triệu chứng đã dẫn đến hồi phục hoàn toàn trong hầu hết các trường hợp.

b. Bảng liệt kê các phản ứng bất lợi

Bảng dưới đây tóm tắt tần suất của các phản ứng bất lợi đã được báo cáo với vắc-xin polysaccharide phế cầu trong các thử nghiệm lâm sàng và/hoặc trong theo dõi hậu mãi, sử dụng quy ước sau: rất thường gặp (≥ 1/10); thường gặp (≥ 1/100 đến < 1/10); ít gặp (≥ 1/1.000 đến < 1/100); hiếm gặp (≥ 1/10.000 đến < 1/1.000); rất hiếm gặp (< 1/10.000); không rõ (không thể ước tính từ các dữ liệu hiện có).

Phản ứng bất lợi	Tần suất
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	
Thiếu máu tan máu*	

Tăng bạch cầu Viêm hạch bạch huyết Bệnh hạch bạch huyết Giảm tiểu cầu**	Không rõ
Rối loạn hệ miễn dịch	
Phản ứng dạng phản vệ Phù thần kinh mạch Bệnh huyết thanh	Không rõ
Rối loạn hệ thần kinh	
Co giật có sốt Hội chứng Guillain-Barré Nhức đầu Dị cảm Bệnh thần kinh-rễ	Không rõ
Rối loạn tiêu hóa	
Buồn nôn Nôn	Không rõ
Rối loạn da và mô dưới da	
Phát ban Nổi mề đay	Không rõ
Rối loạn hệ cơ xương và mô liên kết	
Đau khớp Viêm khớp Đau cơ	Không rõ
Rối loạn toàn thân và tình trạng tại chỗ tiêm	
Sốt (≤ 38,8°C) Phản ứng tại chỗ tiêm: • ban đỏ • chai cứng • đau • đau nhức • sưng • ấm	Rất thường gặp
Sưng lan tỏa chi được tiêm†	Hiếm gặp
Suy nhược Ớn lạnh Sốt Giảm tính cử động của chi được tiêm	Không rõ

Khó chịu Phù ngoại biên††	
Xét nghiệm	
Tăng protein phản ứng C	Không rõ

* ở những bệnh nhân bị rối loạn về huyết học khác

** ở những bệnh nhân bị ban xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát ổn định

† với thời gian khởi phát ngắn từ lúc sử dụng vắc-xin; được xác định bằng cách xem xét lâm sàng các trường hợp báo cáo các thuật ngữ thường dùng là sưng tấy rộng lan tỏa chi được tiêm, viêm mô tế bào tại chỗ tiêm và viêm mô tế bào, tất cả đều mô tả các phản ứng giống viêm mô tế bào.

†† ở chi được tiêm

c. Nhóm đối tượng trẻ em

Một nghiên cứu lâm sàng đã được thực hiện để đánh giá độ an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc-xin polysaccharide phế cầu ở 102 người, bao gồm 25 đối tượng từ 2-17 tuổi, 27 đối tượng từ 18-49 tuổi và 50 đối tượng từ 50 tuổi trở lên. Loại và mức độ nặng của các phản ứng bất lợi tại chỗ tiêm và toàn thân được báo cáo ở những trẻ em từ 2-17 tuổi tương đương với loại và mức độ nặng của các phản ứng bất lợi tại chỗ tiêm và toàn thân được báo cáo ở những người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, tỷ lệ của các đối tượng báo cáo phản ứng bất lợi tại chỗ tiêm và toàn thân cao hơn ở những đối tượng từ 2-17 tuổi so với những người từ 18 tuổi trở lên.

Báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ

Báo cáo các phản ứng bất lợi nghi ngờ sau khi có giấy phép lưu hành thuốc là điều quan trọng. Điều này cho phép theo dõi liên tục cân bằng lợi ích/nguy cơ của thuốc. Các chuyên viên y tế được yêu cầu báo cáo bất kỳ phản ứng bất lợi nghi ngờ nào qua hệ thống báo cáo quốc gia.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Không áp dụng.

ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Nhóm dược lý trị liệu: Vắc-xin phế cầu, kháng nguyên polysaccharide của phế cầu tinh khiết.
Mã ATC: J07AL01

Vắc-xin này được bào chế từ các kháng nguyên polysaccharide của vỏ phế cầu tinh khiết có nguồn gốc từ 23 týp huyết thanh, chiếm khoảng 90% các loại bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn.

Các polysaccharide vỏ phế cầu sau đây bao gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F.

Tính sinh miễn dịch

Sự hiện diện của các kháng thể thể dịch đặc hiệu týp thường được cho là có hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh phế cầu khuẩn. Nồng độ kháng thể tăng gấp ≥ 2 lần sau khi tiêm chủng có liên quan đến hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng về vắc-xin polysaccharide phế cầu đa giá. Tuy nhiên, nồng độ của kháng thể kháng vỏ vi khuẩn cần thiết để bảo vệ chống lại nhiễm phế cầu khuẩn gây ra bởi bất kỳ týp đặc hiệu nào chưa được xác định. Hầu hết những người ≥ 2 tuổi (85-95%) đáp ứng với việc tiêm chủng bằng cách tạo kháng thể kháng hầu hết hoặc tất cả 23 polysaccharide của phế cầu trong vắc-xin. Các polysaccharide vỏ vi khuẩn tạo ra các kháng thể chủ yếu bằng các cơ chế không phụ thuộc tế bào T và gợi ra các đáp ứng kháng thể kém hoặc không nhất quán ở trẻ em < 2 tuổi.

Kháng thể có thể được phát hiện vào tuần thứ 3 sau khi tiêm chủng nhưng có thể giảm ngay sau 3-5 năm sau khi tiêm chủng và sự giảm nhanh hơn có thể xảy ra ở một số nhóm (ví dụ trẻ em và người cao tuổi).

Đáp ứng miễn dịch với 8 trong số các polysaccharide trong vắc-xin polysaccharide phế cầu đã được so sánh sau khi sử dụng một liều đơn của vắc-xin hoặc giả dược. Bốn nhóm đối tượng được thu nhận như được xác định theo độ tuổi (50-64 tuổi và ≥ 65 tuổi) và theo tình trạng tiêm chủng trước đó (không tiêm chủng trước hoặc 1 lần tiêm chủng lúc 3-5 năm trước đó).

- Trước khi tiêm chủng, nồng độ kháng thể cao hơn ở nhóm tiêm chủng lại so với nhóm tiêm chủng cơ bản.

- Ở các nhóm tiêm chủng cơ bản và tiêm chủng lại, nồng độ kháng thể trung bình hình học đối với mỗi týp huyết thanh tăng từ trước khi tiêm chủng đến sau khi tiêm chủng.

- Các tỷ lệ về nồng độ kháng thể trung bình hình học theo týp huyết thanh ở ngày thứ 30 giữa những người được tiêm chủng lại và những người được tiêm chủng cơ bản trong khoảng từ 0,60-0,94 ở nhóm ≥ 65 tuổi và từ 0,62-0,97 ở nhóm từ 50-64 tuổi.

Chưa rõ mối liên quan lâm sàng của đáp ứng kháng thể thấp hơn được quan sát thấy khi tiêm chủng lại so với tiêm chủng cơ bản.

Hiệu lực và hiệu quả

Hiệu lực của vắc-xin polysaccharide phế cầu đa giá đã được xác định đối với viêm phổi do phế cầu khuẩn và vi khuẩn huyết trong các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng được thực hiện ở những công nhân mỏ vàng mới vào nghề ở Nam Phi. Hiệu quả bảo vệ chống lại viêm phổi do phế cầu khuẩn theo tiêu chí đánh giá chính trong các nghiên cứu này là 76,1% với vắc-xin 6 giá và 91,7% với một chế phẩm 12 giá . Trong các thử nghiệm được thực hiện ở các nhóm đối tượng được chỉ định (xem phần **Chỉ định**), hiệu lực của vắc-xin được báo cáo là 50-70% (ví dụ những người bị đái tháo đường, bệnh tim hoặc bệnh phổi mạn tính và không có lách về mặt giải phẫu).

Một nghiên cứu về tỷ lệ týp huyết thanh, dựa trên hệ thống theo dõi phế cầu khuẩn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, đã cho thấy hiệu quả bảo vệ tổng thể 57% chống lại các nhiễm khuẩn xâm lấn gây ra bởi các týp huyết thanh có trong vắc-xin này ở người ≥ 6 tuổi. Tiêm chủng bảo vệ đáng kể chống lại bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn gây ra bởi một số týp huyết thanh riêng lẻ (ví dụ 1, 3, 4, 8, 9V và 14). Đối với các týp huyết thanh khác, số trường hợp được phát hiện trong nghiên cứu này quá nhỏ không thể đưa ra kết luận về sự bảo vệ đặc hiệu týp huyết thanh. Hiệu quả giữa các nhóm bệnh nhân chuyên biệt (ví dụ những người bị bệnh đái tháo đường, bệnh mạch vành, suy tim sung huyết, bệnh phổi mạn tính và không có lách về mặt giải phẫu) là 65-84% và 75% ở những người ≥ 65 tuổi có miễn dịch bình thường. Không thể xác định hiệu quả của vắc-xin đối với một số nhóm bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch; tuy nhiên nghiên cứu này không thể tuyển chọn đủ số lượng bệnh nhân chưa được tiêm chủng từ mỗi nhóm bệnh. Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy rằng việc tiêm chủng có thể đem lại sự bảo vệ ít nhất 9 năm sau khi nhận được liều vắc-xin ban đầu.

Trong một nghiên cứu bệnh-chứng, ước tính hiệu quả giảm đã được báo cáo theo khoảng thời gian tăng sau khi tiêm chủng, đặc biệt là ở những người rất cao tuổi (những người ≥ 85 tuổi).

Hiệu lực lâm sàng của PPV23 cũng đã được đánh giá gần đây trong một thử nghiệm theo thời gian, ngẫu nhiên, đối chứng với giả dược bao gồm 1.006 cư dân tại viện dưỡng lão từ 55 tuổi trở lên (trung bình 84,7 tuổi; độ lệch chuẩn (SD) ± 7,7) tại Nhật. Hiệu lực của vắc-xin là 63,8% chống lại viêm phổi do phế cầu khuẩn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy PPV23 làm giảm tỷ lệ tử vong do viêm phổi do phế cầu khuẩn (không có trường hợp tử vong nào ở nhóm dùng vắc-xin so với 35,1% ở nhóm dùng giả dược).

Một phân tích tổng hợp các RCT (thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên) được công bố vào năm 2013 bởi Cochrane Library đã cho thấy hiệu quả bảo vệ của vắc-xin polysaccharide phế cầu (PPV) là 82% chống lại bệnh phế cầu khuẩn xâm lấn (IPD) theo týp vắc-xin và 87% chống lại viêm phổi do phế cầu khuẩn theo týp vắc-xin.

Vắc-xin này không hiệu quả trong việc phòng ngừa viêm tai giữa cấp, viêm xoang và các nhiễm khuẩn đường hô hấp trên thường gặp khác.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Vì vắc-xin polysaccharide phế cầu là một vắc-xin, các nghiên cứu dược động học đã không được thực hiện.

AN TOÀN TIỀN LÂM SÀNG

Không có thử nghiệm về an toàn tiền lâm sàng nào được thực hiện sử dụng vắc-xin này.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Hộp chứa 1 bơm tiêm đóng sẵn 0,5 ml dung dịch tiêm, kèm 1 kim tiêm riêng biệt.
Hộp chứa 1 bơm tiêm đóng sẵn 0,5 ml dung dịch tiêm, kèm 2 kim tiêm riêng biệt.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C – 8°C). Không làm đông đá.

HẠN DÙNG

28 tháng.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
Tiêu chuẩn cơ sở.

Sản xuất và đóng gói cấp 1 bởi: **Merck Sharp & Dohme LLC**
770 Sumneytown Pike, West Point, PA 19486, USA (Mỹ)

Đóng gói cấp 2 và xuất xưởng bởi: **Merck Sharp & Dohme B.V.**
Waarderweg 39, Haarlem, 2031 BN, Netherlands (Hà Lan)

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
BỘ Y TẾ

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lương Thu Vinh